

가상 건강검진 결과지

Virtual Health Check Report - Sample

중요 안내: 본 문서는 앱 화면에 표시된 제한된 생체·체성분 데이터를 기반으로 생성한 가상 샘플입니다. 실제 의료기관의 검진이나 의사의 대면 진료를 대체하지 않습니다.

문서번호	HU-VHC-20260709-0002	작성일	2026.07.09
성명	이서연	성별/생년월일	여 / 1992.11.05
추정 연령	33세	작성기관	헬스업 가상 건강관리센터

1. 검사 결과 요약

검사항목	측정값	단위	가상 판정	해석 메모
심박	75	bpm	정상	안정시 일반 참고범위 60-100 bpm 기준
혈당	100	mg/dL	경계/주의	공복혈당으로 가정 시 100-125 mg/dL은 공복혈당장애 범위로 해석 가능
혈압	143/93	mmHg	고혈압 의심	반복 측정 평균이 140/90 mmHg 이상이면 고혈압 평가 필요
몸무게	65	kg	기록	단독 수치로 질환 판단 불가
BMI	24.8		과체중/비만 전단계	아시아 성인 기준으로 23 이상은 체중관리 권장 범위
골격근량	19.2	kg	근육량 관리 필요	여성 체성분 기준에서 낮은 편일 수 있어 근력운동 및 단백질 섭취 관리 권장
체지방률	32.4	%	높음	여성 건강관리 관점에서 체지방 감량 및 복부둘레 확인 권장

※ 신장 정보가 화면에 표시되지 않아, 체중 65 kg과 BMI 24.8을 이용하면 추정 신장은 약 161.9 cm입니다. 실제 입력 신장과 다를 수 있습니다.

2. 종합 판정

제공된 수치만 기준으로 심박은 정상 범위이나, 혈압 143/93 mmHg는 고혈압 의심 범위에 해당합니다. 혈당 100 mg/dL은 공복 상태로 측정한 값이라면 경계 범위로 볼 수 있으며, BMI 24.8과 체지방률 32.4%는 체중 및 체지방 관리가 필요한 상태로 해석할 수 있습니다. 단일 시점의 앱 데이터이므로 확정 진단은 불가하며, 반복 측정과 의료기관 상담이 권장됩니다.

3. 추가 확인 권장 항목

항목	권장 내용
혈압 재측정	가정혈압을 1-2주간 아침/저녁으로 안정 후 2회 측정하여 평균 확인
혈액검사	공복혈당, HbA1c, 지질검사, 간기능, 신장기능, 전해질 검사
체성분/복부비만	허리둘레, 체지방률, 골격근량을 동일 기기·동일 조건으로 추적
생활기록	수면, 운동량, 식사, 나트륨 섭취, 음주·흡연 여부, 가족력 확인

가상 의사진단 및 소견서

Doctor Opinion Sample - Not for clinical use

문서번호	HU-VHC-20260709-0002	작성일	2026.07.09
성명	이서연	성별/생년월일	여 / 1992.11.05
추정 연령	33세	작성기관	헬스업 가상 건강관리센터

1. 가상 진단/판정

구분	가상 진단/판정	근거
혈압	고혈압 의심 / 재평가 필요	143/93 mmHg, 단일 측정값 기준
혈당	공복혈당장애 가능성	100 mg/dL - 공복 여부 미확인
체중/BMI	과체중 또는 비만 전단계 관리 권장	BMI 24.8, 추정 신장 약 161.9 cm
체성분	체지방률 높음, 골격근량 관리 필요	체지방률 32.4%, 골격근량 19.2 kg
종합	심혈관·대사 위험요인 관리 필요	고혈압 의심 + 경계 혈당 + 체지방률 상승

2. 의사 소견

- 혈압 143/93 mmHg는 단일 측정값만으로 확정 진단할 수는 없지만, 반복 측정에서도 유사한 수치가 유지된다면 고혈압 평가 및 치료 여부 판단이 필요합니다.
- 혈당 100 mg/dL은 공복 상태로 측정한 값이라면 공복혈당장애 가능성이 있으므로 HbA1c와 식후혈당 확인이 권장됩니다.
- BMI 24.8, 체지방률 32.4%, 골격근량 19.2 kg 조합은 체지방 감량과 근육량 보강이 필요한 패턴으로 볼 수 있습니다. 무리한 절식보다 근력운동과 단백질 섭취, 나트륨 조절을 병행하는 것이 좋습니다.
- 두통, 흉통, 호흡곤란, 시야 흐림, 마비감, 심한 어지러움이 동반되거나 혈압이 180/120 mmHg 이상이면 즉시 진료가 필요합니다.

3. 권고사항

영역	권고 내용	추적 기준
혈압	가정혈압계를 이용해 아침 기상 후와 저녁 안정 시 각각 2회 측정, 평균값 기록	1-2주
혈당	공복/식후 여부를 구분해 기록하고 HbA1c 검사로 3개월 평균 혈당 확인	3개월
운동	중등도 유산소 150분/주 + 전신 근력운동 2-3회/주, 갑작스러운 고강도 운동은 피함	4주 단위
영양	나트륨·당류·야식 줄이기, 단백질은 매 끼니 분산 섭취, 채소·통곡류 비중 확대	상시
진료	반복 혈압이 높거나 가족력/증상이 있으면 내과 또는 가정의학과 상담	가급적 1개월 내

가상 담당의: 홍길동 / 가정의학과 전문의(가상) 면허번호: SAMPLE-00000

소견서 발행기관: 헬스업 가상 건강관리센터 서명: 전자서명(샘플)

가상 처방전

Prescription Sample - Medication not prescribed

본 처방전은 실제 약제 처방전이 아니며, 건강관리 앱/서비스 시연을 위한 문서입니다. 약물 복용은 반드시 실제 의사 또는 약사의 지시에 따라야 합니다.

문서번호	HU-VHC-20260709-0002	작성일	2026.07.09
성명	이서연	성별/생년월일	여 / 1992.11.05
추정 연령	33세	작성기관	헬스업 가상 건강관리센터

1. 약제 처방

약품명	용량/용법	일수	비고
해당 없음	현재 문서는 가상 문서이므로 실제 약물 처방 없음	-	혈압 재측정 및 의료기관 상담 후 필요 시 의사 결정
고혈압 약제 검토	실제 진료 후 적응증 해당 시 결정	-	임의 복용 금지. 임신 가능성, 신장기능, 전해질, 병용약 확인 필요

2. 생활습관 처방

처방 영역	세부 처방	빈도/기간
혈압 관리	나트륨 섭취 줄이기, 국물·가공식품·짠 반찬 제한, 카페인 과다 섭취 피하기	상시
유산소 운동	빠르게 걷기, 자전거, 수영 등 숨이 약간 찰 정도의 중등도 운동	주 5회, 1회 30분
근력 운동	스쿼트, 런지, 로우, 푸시업 변형, 플랭크 등 전신 대근육 운동	주 2-3회
체지방 관리	단 음료·야식·정제 탄수화물 섭취를 줄이고 단백질·채소 중심 식사	4주 후 재평가
자가 측정	혈압은 안정 후 2회 평균, 혈당은 공복/식후 여부를 구분해 기록	매일 또는 주 3회
추적 검사	공복혈당, HbA1c, 지질검사, 신장기능, 소변검사 등 확인	1-3개월

3. 복약 및 안전 안내

- 이 문서만 보고 혈압약, 당뇨약, 다이어트약, 이뇨제, 보충제를 임의로 시작하지 마십시오.
- 이미 복용 중인 약이 있다면 약 이름, 용량, 복용 시간을 정리하여 진료 시 제시하십시오.
- 운동 중 흉통, 호흡곤란, 어지러움, 실신감, 비정상적인 심계항진이 있으면 즉시 중단하고 진료를 받으십시오.
- 본 문서는 앱 데이터 흐름, 건강검진 PDF 생성, AI 소견 생성 기능을 시연하기 위한 샘플입니다.

가상 담당의: 홍길동 / 가정의학과 전문의(가상) 면허번호: SAMPLE-00000

처방전 발행기관: 헬스업 가상 건강관리센터 서명: 전자서명(샘플)